

LES CANCERS DE LA CAVITE BUCCALE

Pr BENBOUZID ANAS

Service d'ORL Hôpital Des Spécialités Rabat

Objectifs

- Distinguer et surveiller une ulcération buccale en rapport avec un cancer de la cavité buccale
- Reconnaître les facteurs favorisant la survenue des cancers de la cavité buccale
- Ne pas oublier d'examiner les zones cachées de la cavité buccale pour ne pas passer devant un cancer
- Pratiquer au moindre doute une biopsie devant toute lésion suspecte de la cavité buccale
- Classer les cancers de la cavité buccale après palpation des ganglions du cou
- Pouvoir orienter le patient au plus vite vers un centre spécialisé

Introduction

- Les cancers de la cavité buccale intéressent le plancher de la bouche, la langue, la face interne des joues, les gencives et le voile du palais.
- La majorité de ces cancers trouvent leur point de départ au niveau de la muqueuse (90% des cas sont des épithéliomas malpighiens) et rarement depuis le tissu lymphoïde et les glandes salivaires.
- L'extension des cancers de la cavité buccale est surtout locorégionale.
- Fréquence des cancers multiples (7 à 14% des cas).
- Ce sont des cancers très lymphophiles: L'atteinte ganglionnaire conditionne le pronostic et les récidives.
- Le développement de la tumeur et son traitement retentissent sur la mastication, la déglutition, les sécrétions salivaires, indirectement sur la phonation et la respiration.
- Le maintien ou la réadaptation de ces fonctions constitue une des préoccupations du thérapeute

I-Anatomo-pathologie

A- Aspects macroscopiques

- Le plus souvent la lésion se développe sur une muqueuse saine et revêt une des formes suivantes :
 - Ulcéreuse.
 - Végétante.
 - Ulcéro-végétante.
- Quelque fois, elle prend un aspect particulier :
 - Nodule interstitiel.
 - Epithélioma en surface.
- Elle peut émerger au niveau d'une lésion préexistante, (précancéreuse.)

B-Histopathologie :

- 90% des cancers de la cavité buccale sont développés aux dépens des muqueuses : carcinome spinocellulaire.
- 5% aux dépens de formation glandulaire (adénocarcinomes).

II- Dissémination lymphatique

Aspects morphologiques :

Elle constitue un risque évolutif très fréquent de la maladie.

Les adénopathies peuvent être multiples et on note en moyenne 30% de ganglions cliniquement envahis au premier examen.

Il n'existe aucun parallélisme entre le volume tumoral et le volume ganglionnaire.

Une adénopathie cervicale peut être révélatrice d'une tumeur.

Aspects topographiques :

- Le siège de l'adénopathie est tributaire de celui de la tumeur.

Deux relais sont importants :

- le ganglion de Kuttner (groupe sous-digastrique)
- Le ganglion de Poirier (groupe sus-omo-hyoïdien)

Elles sont en règle homo-latérales. Parfois bilatérales en cas de lésions médiane ou para-médiane.

Rarement, elles sont controlatérales.

III-Etio-épidémiologie

❑ **Age** : entre 30 et 70 ans

❑ **Sexe** : Grande disproportion homme/femme : l'homme dans 95% des cas

❑ **Facteurs favorisants** : facteurs irritatifs locaux à l'origine d'une inflammation chronique

- Alcoolisme
- Tabagisme
- Papillomavirus (HPV)+++
- mauvaise hygiène bucco-dentaire
- Génétique
- Maladies chronique de la muqueuse: 20% des cas de cancers de la cavité buccale.

IV- Etude clinique

Les cancers de la cavité buccale sont accessible cliniquement mais leur diagnostic est souvent tardif en raison de la latence fonctionnelle et de la négligence des patients.

L'intérêt d'un diagnostic rapide, qui contribue à la précocité du traitement et à l'amélioration du pronostic.

Ces cancers ont de nombreux points communs:

- leur allure clinique,
- leur modalité d'extension,
- les étapes de leur diagnostic.

A - SIGNES D'APPEL

-**Souvent frustes**, mais persistants. Ils devront conduire à un examen clinique minutieux.

.Picotements, brûlures au contact d'aliments épicés ou d'alcool, sensation de corps étrangers, gêne à la mastication, difficultés d'élocution, d'hypersialorrhée parfois striée de sang, et d'haleine fétide.

.Des douleurs progressives à caractère pénible, tenace puis douleurs permanentes, irradiant vers l'oreille dans les localisations postérieures (otalgie réflexe à grande valeur sémiologique).

.Trismus est révélateur d'un carcinome de la commissure intermaxillaire, il traduit un développement tumoral important et grève le pronostic.

.Une érosion, une fissure ou un bourgeonnement de la muqueuse devront faire rechercher une induration, un saignement ou une surélévation des berges.

.L'état général restera bien conservé au début.

-**Parfois très discrets** et la lésion sera découverte lors de soins dentaires ou à l'occasion d'un bilan systématique.

Mais il faut insister sur la valeur révélatrice d'une adénopathie cervicale chronique le plus souvent sous-digastrique ou sous-mandibulaire

B- EXAMEN CLINIQUE

Un examen minutieux et systématique basé sur l'inspection directe, indirecte et la palpation.

Il devra permettre l'exploration de chaque site anatomique en particulier les zones d'accès difficile (base de langue, sillon amygdalo-glosse, plancher buccal...) par traction linguale ou par refoulement.

1-Inspection :

Aspect tumoral : - le plus souvent la lésion se développe sur une muqueuse saine sous forme:

ulcéreuse, fissuraire, végétante ou ulcéro-végétante.

-Parfois la tumeur apparaîtra sur une lésion préexistante.

Les aspects habituels pouvant être masqués par des phénomènes inflammatoires ou une surinfection ainsi que par une très mauvaise hygiène bucco-dentaire.

2-Palpation :

l'induration profonde témoin du caractère infiltrant de la tumeur.

- Son degré d'infiltration, son extension aux structures voisines.

- Un toucher endo- buccal est indispensable. ,

- Un schéma de la lésion est effectué et les dimensions de la tumeur primitive doivent être chiffrées.

- Des photographies sont également souhaitables.

3- Examen cervical:

Le diagnostic évoqué sur les premières constatations cliniques impose :

- l'examen des parties molles cervico-faciales à la recherche de signes d'extension macroscopique (nodule de perméation).
- l'examen des aires ganglionnaires cervicales doit être minutieux et méthodique. Il précisera la topographie, le nombre des adénopathies, leur taille, leur consistance, leur situation (homo, contro ou bilatérale) ainsi que leur mobilité ou leur fixité par rapport à la peau, aux plans musculaires et à l'axe vasculaire.
- Un schéma daté sera effectué.

4- Reste de l'examen O.R.L. :

- Examen oropharyngé, laryngé, rhinologique, rhinopharyngé et otologique sera effectué à la recherche d'une deuxième localisation tumorale.
- Examen général : A la recherche d'éventuelles métastases.

C- EXAMENS COMPLEMENTAIRES

Ils revêtent une importance particulière pour préciser le degré d'envahissement tumoral:

1-Bilan radiologique :

Il sera judicieusement orienté en fonction de la localisation et de l'extension tumorale.

- **Orthopantomogramme, défilé maxillaire, clichés occlusaux et rétro-alvéolaires, incidence de Blondeau**, tenteront d'apprécier l'extension osseuse.
- **Echographie cervicale** pour mieux apprécier l'extension ganglionnaire. Elle permet de découvrir les adénopathies infra-cliniques chez les patients N0, tout en sachant qu'un tel examen n'apporte aucune information quant à la nature réelle de l'adénopathie.
- **Tomodensitométrie** : Son intérêt réside dans la précision de l'extension tumorale vers les structures profondes de la face et du cou (espaces parapharyngés, régions tubérositaires, fosse infra-temporale, plans profonds du cou).
- **Imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM)**: permet une meilleure définition de l'extension profonde des parties molles (langue).
- **Petscanner** : la recherche de métastases.

2-Panendoscopie du tractus aéro-digestif supérieur:

A la recherche d'une deuxième localisation tumorale(10-15%) ++++.

3- Bilan de l'état général

Radiographie pulmonaire, échographie hépatique, scintigraphie osseuse à la recherche d'éventuelles métastases.

Bilan biologique : état d'équilibre hydro-électrolytique et nutritionnel, recherche de tares pouvant contre-indiquer une anesthésie générale.

V- Diagnostic

A- DIAGNOSTIC POSITIF :

Le plus souvent le diagnostic est évident. Il doit toujours être confirmé par une **biopsie**. Celle-ci doit obéir à certains principes:

- Prélèvement suffisamment profond,
- A cheval sur la limite de la lésion
- Précédant le traitement.

Il faudrait rechercher un autre cancer des V.A.DS et des métastases à distance.

A l'issue de cette démarche diagnostic clinique et radiologique, on peut classer la tumeur selon la classification TNM

Classification TNM

T

Tis : carcinome in situ

T1 : tumeur < 2 cm

T2 : tumeur 2-4 cm

T3 : tumeur > 4 cm

T4 : tumeur étendue à l'os ou aux muscles profonds

N

No : pas d'adénopathie palpable

N1 : ganglion homolatéral < 3 cm

N2a : 1 ganglion homolatéral > 3 cm et < 6 cm

N2b : plusieurs ganglions < 6 cm homolatéraux

N2c : un ou plusieurs ganglions bi- ou controlatéral < 6 cm

N3 : un ou plusieurs ganglions > 6 cm

M

Mo : absence de métastase

M1 : présence de métastases

B- DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

Il sera facile d'éliminer:

- La tuberculose ou la syphilis buccale ;
- Les tumeurs bénignes de type papillome, neurinome ou fibrome ;
- Les ulcérations traumatiques, en particulier dues aux prothèses dentaires. Leur persistance au delà de quinze jours impose une biopsie.
- Les lésions dites pré-épithéliomateuses (érythroplasies, leucoplasies).

Les lésions rouges hautement suspectes feront l'objet d'une exérèse avec contrôle histologique.

Les lésions blanches simples imposeront une surveillance régulière et toute modification de leurs caractéristiques (fissuration, induration) conduira à une biopsie.

VII- Formes topographiques

A- La langue

1 - La langue mobile :

Située en avant du V lingual et au dessus du sillon pelvi- lingual. 75% des tumeurs siègent dans cette portion.

*Le diagnostic est souvent **tardif** en raison de la latence clinique.

*L'examen clinique doit étudier la **protraction linguale** (mobilité ou fixité)

*la palpation appréciera l'extension en profondeur et en largeur.

*L'ulcération est la lésion la plus fréquente, avec souvent atteinte des bords de la langue dans la portion moyenne (marginale) (50% des cas).

*L'envahissement ganglionnaire est fréquent (40% lors du premier examen). L'extension ganglionnaire s'effectue le plus souvent vers le groupe sous-mandibulaire et le ganglion sous-digastrique de Kuttner. Il existe dans 6% des cas des ganglions contro- latéraux

2 - La base de langue :

Les signes sont très tardifs : signes hémorragiques, adénopathies révélatrices, otalgies, dysphagie.

Le diagnostic est difficile, il repose essentiellement sur le toucher endo-buccal au niveau de la base de langue et l'examen endoscopique.

Il va mettre en évidence une lésion bourgeonnante, ulcéreuse ou infiltrante.

Les adénopathies sont souvent bilatérales et au niveau du ganglion sous-digastrique.+++

B- Le plancher buccal

C'est une gouttière horizontale, en fer à cheval située entre la langue et l'arc mandibulaire. Il comprend deux régions:

1 - le plancher antérieur :

Son accès est aisé. Le plus souvent il s'agit d'une lésion ulcéreuse.

La tumeur va s'étendre vers la langue, vers l'avant elle peut envahir la muqueuse de recouvrement de la table interne de la mandibule, puis l'os alvéolaire.

L'envahissement ganglionnaire est fréquent. Il existe souvent des adénopathies bilatérales.

2 - le plancher postérieur :

- C'est la région du plancher situé en regard des molaires, cachée par les bords de la langue.
- Ces lésions sont plus difficiles à dépister.
- L'extension est souvent très rapide vers la mandibule, vers la commissure inter-maxillaire et vers le sillon amygdalo-glosse.
- Les adénopathies sont en général homolatérales.

C- La face interne des joues

- Région très accessible à l'examen permettant une découverte aisée de la tumeur.
- La tumeur a un aspect végétant, surélevé en plateau, en chou-fleur.
- Sa présence entraîne une gêne à la mastication.
- La tumeur est souvent traumatisée par le contact des dents.
- Extension se fait en surface et en profondeur vers le buccinateur et la peau.
- Les adénopathies sont précoces et fréquentes (50% des cas au premier examen).

D – la commissure inter-maxillaire

- Elle s'étend de la région rétro-molaire inférieure vers son homologue supérieur.
- Elle entraîne un trismus associé à un syndrome douloureux.
- L'extension est très rapide: vers la joue, vers le vestibule, vers les gencives, vers le plancher de la bouche ou vers le voile du palais.
- Ces tumeurs sont graves, d'une part par le retentissement fonctionnel et d'autre part, par leur drainage lymphatique très riche.

VIII- Méthodes thérapeutiques

A - METHODES CHIRURGICALES:

Toujours après mise en état de la cavité buccale, alimentation hypercalorique, rééquilibration hydro-électrolytique. **1 - L'exérèse tumorale:** Il convient de réaliser une exérèse carcinologique.

Le but : l'éradication complète de la tumeur qui doit être large avec une marge de sécurité de 1cm . Elle est encadrée par un examen histologique extemporané.

Pour la langue l'exérèse est faite selon le degré d'extension tumorale à l'IRM.

- Pour le reste de la cavité buccale, en particulier le plancher de la bouche, l'exérèse muqueuse peut être associée à une exérèse osseuse partielle ou interruptrice, selon l'étendue de l'extension tumorale.

Cette exérèse peut également intéresser le plan cutané.

2-Chirurgie ganglionnaire:

- Le curage ganglionnaire est sous digastrique_ sus-omo-hyoïdien.
- De type fonctionnel ou radical. Homo ou bilatéral.
- Le curage doit être conservateur, c'est à dire pratiquer l'exérèse du tissu cellulo-graisseux contenant les voies lymphatiques et les ganglions, mais en respectant le nerf spinal, la veine jugulaire interne et le sterno-cleido-mastoidien.
- Le curage conservateur est réalisée si les ganglions sont mobiles, et < 2 cm.
- Les adénopathies fixées ou > 2 cm nécessitent un curage radical.

3- La reconstruction

L'exérèse crée une perte de substance qui nécessite une reconstruction chirurgicale employant des procédés classiques de chirurgie plastique. Cette reconstruction permet une meilleure réinsertion socio-professionnelle et familiale.

- **la reconstruction muqueuse:** On utilise essentiellement des lambeaux loco-régionaux:

- . Lambeau temporo-frontal
- . Lambeau naso-génien en îlot
- . Lambeau myo-cutané de grand pectoral ou de trapèze .
- . Lambeau libre cutané ou myo-cutané.

- **la reconstruction cutanée :**

Elle est également assurée par les lambeaux loco-régionaux.

- **La reconstruction osseuse:** par des greffons osseux libres revascularisés ou non, soit par des endo-prothèses en titanium.

B - LA RADIOTHERAPIE :

Utilise les rayonnements gamma du Cobalt 60

- Elle peut être utilisée seule pour le traitement de la tumeur primitive et des aires ganglionnaires.



La dose pour la tumeur primitive est de 70 à 75 Gy.

- L'irradiation post-opératoire des aires ganglionnaires en cas d'envahissement histologique.



La dose est de 50 Gy avec un surdosage de 15 Gy en cas de rupture capsulaire.

C - LA CURIETHERAPIE: Utilise l'iridium 192.

Elle peut être utilisée de 2 manières :

- Les gouttières vécrices placées sous anesthésie locale.
- Les tubes plastiques placés sous anesthésie générale.

Elle peut être combinée à la chirurgie ou à la radiothérapie externe.

D - LA CHIMIOOTHERAPIE

Il peut s'agir d'une mono mais surtout d'une polychimiothérapie utilisant le méthotrexate, la bléomycine et le 5 Fluoro-Uracile.

IX- Surveillance

La surveillance est indispensable, elle doit être régulière et à vie. Elle est clinique, avec une biopsie au moindre doute. Des examens complémentaires seront demandés en fonction de la symptomatologie clinique retrouvée.

Il convient particulièrement de déceler :

- Une récurrence tumorale (non stérilisation des lésions).
- Une récurrence ganglionnaire.
- Une nécrose post-radiothérapique (muqueuse, gingivale ou ostéoradionécrose mandibulaire).
- Une deuxième localisation tumorale.
- Une évolution métastatique.

Conclusion

En dépit des indéniables progrès thérapeutiques et du soin apporté à la réhabilitation et à la réinsertion des patients, les cancers de la cavité buccale restent des affections au pronostic sévère, souvent gravement invalidantes.

C'est souligner l'importance des mesures de prévention (tabagisme et alcoolisme) et du dépistage précoce de ces néoplasies.